Клинические рекомендации

Злокачественные опухоли слюнных желёз

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C06.9** — Рта неуточненное **C07** — Злокачественное новообразование околоушной слюнной железы **C08** — Злокачественное новообразование других и неуточненных больших слюнных желез
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 14.08.2024, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"; Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»; Общероссийская общественная организация «Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи»; Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/116_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Этиология и эпидемиология 3

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 5

3. Диагностика 5

3.1 Критерии диагноза 5

3.2 Жалобы и анамнез. Физикальное обследование 5

3.3 УЗИ и тонкоигольная аспирационная биопсия 5

3.4 КТ или МРТ лицевого отдела черепа 6

3.5 КТ органов грудной полости 6

3.6 ПЭТ всего тела 6

3.7 Патолого-анатомическое заключение 6

4. Лечение 6

4.1 Выбор метода лечения 6

4.2 Хирургическое лечение 7

4.3 Лучевая терапия 8

4.4 Лекарственная терапия 8
4.5 Медицинская реабилитация 9
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 10
5.1 Диспансерное наблюдение 10
5.2 Показания к госпитализации 10
6. Источник и актуальность 11
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 11

1. Основные положения

- Злокачественными опухолями слюнных желёз называют злокачественные новообразования слюнных желёз, различающиеся по морфологическому строению. Основную группу (95%) составляют эпителиальные опухоли; в 80–90% случаев они развиваются в больших слюнных железах.
- **Обследование при подозрении на злокачественную опухоль**
  1. УЗИ мягких тканей и лимфатических узлов шеи;
  2. тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) первичной опухоли и подозрительных лимфатических узлов под контролем УЗИ с цитологическим исследованием;
  3. КТ органов грудной полости для исключения отдалённых метастазов;
  4. КТ или МРТ лицевого отдела черепа с контрастированием при подозрении на распространение на челюсти и основание черепа.
- Основным методом радикального лечения эпителиальных опухолей является хирургическое вмешательство; минимальный объём при подозрении на злокачественную опухоль околоушной железы — субтотальная резекция. Объём операции и послеоперационная лучевая терапия зависят от стадии и гистологии.
- При стадии T4b и невозможности радикальной операции проводится лучевая или одновременная химиолучевая терапия с учётом общего состояния.
- **Наблюдение после лечения**
  1. первые 1–2 года: **каждые 3–6 месяцев**;
  2. 3–5-й год: **1 раз в 6–12 месяцев**;
  3. после 5 лет: **ежегодно** или при появлении жалоб.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Определение КР охватывает злокачественные новообразования слюнных желёз разного морфологического строения. К большим слюнным железам относят околоушную, поднижнечелюстную и подъязычную.

2.2 Этиология и эпидемиология

Основные этиологические факторы

1. воспалительные заболевания;
2. алиментарные факторы;
3. гормональные и генетические нарушения;
4. курение.

Новообразования слюнных желёз составляют 1–5% всех злокачественных опухолей и 3% опухолей головы и шеи; пик заболеваемости приходится на возраст 15–39 лет. Эпителиальные опухоли в 80–90% случаев развиваются в больших слюнных железах, в 10% — в малых.

2.3 Классификация

Гистологическая классификация ВОЗ (5-е изд., 2022): злокачественные эпителиальные опухоли

1. мукоэпидермоидный рак;
2. аденокистозный рак;
3. ацинарноклеточная и секреторная карцинома;
4. полиморфная аденокарцинома;
5. протоковая карцинома слюнных желёз, миоэпителиальная и эпителиально-миоэпителиальная карцинома;
6. карцинома из плеоморфной аденомы, карциносаркома;
7. плоскоклеточный рак, лимфоэпителиальная карцинома;
8. другие (гиалинизирующая светлоклеточная, базальноклеточная, муцинозная, сальная аденокарцинома, сиалобластома и др.).

Классификация включает также неопухолевые эпителиальные поражения и доброкачественные опухоли (плеоморфная аденома, опухоль Уортина, онкоцитома и другие).

Степень злокачественности

1. **трёхступенчатая (высоко-, умеренно-, низкодифференцированная)** — мукоэпидермоидный рак, полиморфная аденокарцинома, аденокарцинома БДУ, плоскоклеточный рак
2. **двухступенчатая (low/high grade)** — внутрипротоковая карцинома
3. **аденокистозный рак** — указывается доля солидного компонента; более 30% солидных структур ассоциировано с агрессивным течением

Течение по гистотипу

1. **индолентное** — секреторная, микросекреторная карцинома, базальноклеточная и склерозирующая микрокистозная аденокарцинома, лимфоэпителиальная карцинома, сиалобластома
2. **агрессивное** — протоковая карцинома, миоэпителиальная карцинома, карцинома из плеоморфной аденомы, карциносаркома

Первичная опухоль (T), TNM 8-е изд.

1. **T1** — **2 см или менее**, без распространения за пределы паренхимы железы
2. **T2** — **более 2 см, но не более 4 см**, без распространения за пределы паренхимы
3. **T3** — **более 4 см** и (или) распространение за пределы паренхимы
4. **T4a** — распространение на кожу, нижнюю челюсть, слуховой проход и (или) лицевой нерв
5. **T4b** — распространение на крыловидные отростки, основание черепа или внутреннюю сонную артерию

Регионарные лимфатические узлы (cN)

1. **N1** — метастаз в одном узле на стороне поражения **3 см и менее**, без экстранодального распространения (ENE)
2. **N2** — метастаз в одном узле **более 3 см, но не более 6 см** (N2a), в нескольких узлах на стороне поражения (N2b), с обеих или противоположной стороны (N2c) — до 6 см, ENE отсутствует
3. **N3** — метастаз **более 6 см** без ENE (N3a) или любого размера с ENE

По данным планового патолого-анатомического исследования (pN) метастаз ≤ 3 см с ENE относится к N2a; метастазы с ENE в одном ипсилатеральном узле более 3 см, множественные или контралатеральные — к N3b.

Группировка по стадиям

Стадия	Сочетание T, N, M
I	T1 N0 M0

Стадия	Сочетание T, N, M
II	T2 N0 M0
III	T3 N0 M0; T1–T3 N1 M0
IVA	T1–T3 N2 M0; T4a N0–N2 M0
IVB	любое T N3 M0; T4b любое N M0
IVC	любое T, любое N, M1

2.4 Клиническая картина

Течение определяется локализацией, распространённостью и морфологическим строением. Как правило, опухоль имеет вид безболезненного узлового образования плотноэластической консистенции, не спаянного с кожей, подвижного при пальпации.

Признаки распространённого процесса

1. инфильтрация кожи;
2. ограничение смещаемости образования;
3. болезненность при пальпации;
4. парез мимической мускулатуры — крайне неблагоприятный прогностический признак.

Опухоль глоточного отростка околоушной железы снаружи не пальпируется: определяется лишь незначительная припухлость в околоушной области, а со стороны глотки — деформация её стенки. Опухоль растёт в сторону ротовой полости, кнаружи её распространению препятствует нижняя челюсть.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнеза: наличие новообразования;
2. физикального обследования: осмотр, пальпация образования, прилежащих тканей и регионарных лимфатических узлов;
3. цитологического исследования материала ТАБ, трепан-биопсии, core-биопсии, инцизионной или эксцизионной биопсии;
4. патолого-анатомического исследования биопсийного (операционного) материала;
5. инструментальных исследований: УЗИ, КТ, МРТ, ПЭТ-КТ.

3.2 Жалобы и анамнез. Физикальное обследование

У всех пациентов тщательно собирают жалобы и анамнез, чтобы выявить факторы, влияющие на выбор тактики лечения.

Физикальный осмотр включает

1. осмотр и бимануальную пальпацию очага поражения;
2. пальпацию регионарных лимфатических узлов;
3. оценку нутритивного статуса.

3.3 УЗИ и тонкоигольная аспирационная биопсия

Всем пациентам с подозрением на злокачественную опухоль выполняют УЗИ мягких тканей и лимфатических узлов шеи с ТАБ подозрительных узлов для верификации и определения распространённости.

ТАБ первичной опухоли и подозрительных лимфатических узлов под УЗИ-навигацией с цитологическим исследованием проводится всем пациентам: она отличает злокачественную опухоль от доброкачественной и уточняет распространённость.

Тактика по результату

1. **цитология неинформативна** — патолого-анатомическое исследование материала трепан-биопсии, core-биопсии, инцизионной или эксцизионной биопсии
2. **опухоль верифицирована** — определить гистологический тип и степень дифференцировки, если она применима к гистотипу
3. **сомнительный результат** — обязательная повторная биопсия в объёме, достаточном для иммуногистохимического исследования
4. **отрицательный результат** — повторная биопсия целесообразна при убедительных клинических или рентгенологических признаках злокачественной опухоли

3.4 КТ или МРТ лицевого отдела черепа

При местно-распространённом процессе и подозрении на распространение на нижнюю или верхнюю челюсть, основание черепа выполняется КТ или МРТ лицевого отдела черепа с внутривенным контрастированием.

3.5 КТ органов грудной полости

Выполняется всем пациентам со злокачественными опухолями слюнных желёз для исключения отдалённых метастазов.

3.6 ПЭТ всего тела

Позитронная эмиссионная томография всего тела с туморотропными радиофармпрепаратами уточняет распространённость при подозрении на отдалённые метастазы.

3.7 Патолого-анатомическое заключение

Параметры, которые отражаются в заключении

1. размер опухоли;
2. гистологический вариант;
3. степень дифференцировки или наличие high grade трансформации;
4. лимфоваскулярная и (или) периневральная инвазия;
5. pT;
6. pN с числом исследованных и поражённых узлов, экстранодальным распространением;
7. статус краёв резекции и минимальное расстояние от опухоли до края.

---

4. Лечение

4.1 Выбор метода лечения

Ниже приведены принципы лечения эпителиальных опухолей. Саркомы и лимфомы слюнных желёз лечат так же, как при других локализациях, по соответствующим клиническим рекомендациям.

Хирургическое вмешательство является основным методом радикального лечения. Минимальный объём операции при подозрении на злокачественную опухоль околоушной железы — субтотальная резекция околоушной железы.

Лечение по стадиям

Стадия	Лечение
T1–T2 N0	полное удаление первичной опухоли; послеоперационная ДЛТ при аденокистозном раке, низкодифференцированном мукоэпидермоидном раке, положительных краях, периневральной инвазии
T1–T2 N+ M0	удаление опухоли с шейной лимфаденэктомией, затем ДЛТ
T3–T4a N0 M0	полное удаление опухоли (при аденокистозном, протоковом раке и аденокарциноме — с шейной лимфаденэктомией), затем ДЛТ; при неблагоприятных гистологических признаках рассматривают одновременную ХЛТ
T3–T4a N+ M0	удаление опухоли с шейной лимфаденэктомией, затем ДЛТ; при неблагоприятных гистологических признаках рассматривают одновременную ХЛТ
T4b или невозможность радикальной операции	лучевая терапия или одновременная ХЛТ с учётом общего состояния; при невозможности радикального лечения — лекарственная терапия
Локорегионарный рецидив	полное удаление с решением вопроса о ЛТ или ХЛТ (после предшествующей ЛТ — о повторной); при неоперабельном рецидиве — ЛТ, ХЛТ или лекарственное лечение

Неблагоприятными гистологическими признаками считают низкодифференцированную опухоль, положительные края резекции, периневральную инвазию, сосудистую эмболию.

4.2 Хирургическое лечение

Перед лечением онколог, специализирующийся на опухолях головы и шеи

1. оценивает адекватность биопсийного материала, стадирования и визуализации (КТ, МРТ);
2. исключает синхронную первичную опухоль;
3. оценивает функциональный статус и возможность операции;
4. составляет план наблюдения: обследование зубов, питание, реабилитация.

Объём операции не уменьшают из-за регрессии опухоли до лечения; расширяют только при прогрессировании.

Признаки нерезектабельности (T4b)

1. значительное поражение крылонёбной ямки, тяжёлый тризм из-за инфильтрации крыловидных мышц;
2. макроскопическое распространение на основание черепа (эрозия крыловидных пластинок или основной кости, расширение овального отверстия);
3. охват общей или внутренней сонной артерии — **≥ 270° окружности** по КТ и МРТ;
4. распространение из лимфатических узлов на кожу, средостение, предпозвоночную фасцию или шейные позвонки.

Первичную опухоль по возможности удаляют единым блоком. Если опухоль прилежит к нерву, его выделяют и резецируют до чистого края под контролем срочного исследования замороженных срезов; предпочтительна одномоментная реконструкция нерва. Чистым считается край **≥ 5 мм** от инвазивного края опухоли, близким — **менее 5 мм**.

4.3 Лучевая терапия

Самостоятельная дистанционная ЛТ

1. первичный очаг и клинически определяемые метастазы (узлы ≥ 1 см или с центральным некрозом): СОД 66–70 Гр;
2. профилактическое облучение шеи (уровни Ib–III) на стороне поражения — при низкодифференцированных и местно-распространённых (T3–4) опухолях, кроме ацинарноклеточного и аденокистозного рака;
3. облучение противоположной половины шеи (I–III уровни) до СОД 50 Гр — при метастазах в нескольких узлах и при опухолях поднижнечелюстной железы;
4. режим: РОД 2 Гр, 5 раз в неделю, 6–7 недель.

Послеоперационная ЛТ

1. показания: низкодифференцированная опухоль, положительные или близкие края, перineвральная инвазия, сосудистая эмболия, метастазы в узлах, T3–4a, аденокистозный рак, нарушение целостности узла при удалении;
2. ложе опухоли (при перineвральной инвазии — с каналом лицевого нерва до коленчатого ганглия, язычным и подъязычным нервами до основания черепа): СОД 50–66 Гр;
3. регионарные зоны I–III при всех опухолях поднижнечелюстной железы, кроме ацинарноклеточной и аденокистозной в стадии T1: СОД 50 Гр;
4. начало — **через 6–8 недель** после операции; РОД 2 Гр, 5 раз в неделю, 5–6,5 недели.

4.4 Лекарственная терапия

Одновременная ХЛТ: ЛТ на первичный очаг (70 Гр) и лимфатические узлы (50 Гр) по 2 Гр в сутки 5 дней в неделю 7 недель; цисплатин 100 мг/м^2 на фоне гипергидратации в 1, 22 и 43-й дни ЛТ (суммарно 300 мг/м^2).

При отдалённых метастазах и состоянии ECOG 0–3 проводится лекарственная терапия, выжидательная тактика при медленной прогрессии, селективная метастазэктомия или антиандрогенная терапия при гиперэкспрессии рецепторов к андрогенам.

Предпочтительные режимы ХТ при рецидивных неоперабельных опухолях и инкурабельных метастазах

1. #паклитаксел 175 мг/м^2 в 1-й день + карбоплатин AUC 5–6, каждые 3 недели;
2. доксорубицин 50 мг/м^2 в 1-й день + #блеомицин 30 мг в 1–5-й дни + цисплатин 20 мг/м^2 в 1–5-й дни, каждые 3 недели;
3. доксорубицин 60 мг/м^2 в 1-й день + #блеомицин 10 мг в 1–5-й дни + #винкристин 1,4 мг/м^2 в 1-й и 8-й дни, каждые 3 недели;
4. цисплатин 50 мг/м^2 + доксорубицин 50 мг/м^2 + #циклофосфамид 500 мг/м^2 в 1-й день, каждые 4 недели.

Дополнительные режимы

1. доксорубицин 60 мг/м^2 + цисплатин 40 мг/м^2 в 1-й день, каждые 3 недели;
2. доксорубицин 30 мг/м^2 + #цисплатин 50 мг/м^2 в 1-й и 8-й дни, каждые 3 недели;
3. #паклитаксел 60–80 мг/м^2 + #карбоплатин AUC 2 еженедельно;
4. #гемцитабин 1000 мг/м^2 в 1-й и 8-й дни + цисплатин 70 мг/м^2 во 2-й день, каждые 3 недели;
5. цисплатин 80 мг/м^2 в 1-й день + #винорелбин 25 мг/м^2 в 1-й и 8-й дни, каждые 3 недели.

Кумулятивная доза доксорубицина не должна превышать **450–500 мг/м^2**.

Таргетная и гормональная терапия при рефрактерности к стандартной ХТ

1. **мутация ERBB2 (HER2)** — #трастузумаб 2 мг/кг еженедельно (нагрузочная 4 мг/кг) в монотерапии или 6 мг/кг раз в 3 недели (нагрузочная 8 мг/кг) в комбинации
2. **рецепторы к андрогенам, ECOG 0–3** — #бикалутамид 150 мг 1 раз в сутки; для максимальной андрогенной блокады — #гозерелин 3,6 мг раз в 28 дней (или 10,8 мг раз в 84 дня) + #бикалутамид 50 мг в сутки
3. **мутация BRAF** — #дабрафениб 150 мг 2 раза в сутки + #траметиниб 2 мг 1 раз в сутки

Для поиска мишеней проводится комплексное геномное профилирование (NGS) ткани опухоли или жидкостной биопсии.

1. **MSI-H/dMMR или TMB ≥ 10 mut/Mb** — по решению врачебной комиссии #пембролизумаб 200 мг раз в 3 недели, не более 24 месяцев
2. **слияние гена NTRK** — ларотректиниб 100 мг 2 раза в сутки или энтректиниб 600 мг в сутки
3. **аденокистозный рак** — #ленватиниб 24 мг в сутки или #сорафениб 800 мг в сутки

Обезболивание проводится по клиническим рекомендациям «Хронический болевой синдром у взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи».

4.5 Медицинская реабилитация

Всем пациентам показана пререабилитация: физическая подготовка, психологическая и нутритивная поддержка, информирование. Она ускоряет восстановление и снижает частоту осложнений. Перед операцией полезна лечебная физкультура, перед комплексным лечением — профилактическая гимнастика и обучение глотанию.

Показания к нутритивной поддержке перед операцией (хотя бы одно)

1. непреднамеренное снижение массы тела **на 10% и более за 3 месяца**;
2. индекс массы тела **менее 18,5 кг/м²**;
3. ухудшение возможности приёма пищи за последнюю неделю;
4. калорийность питания **менее 1500 ккал в сутки**.

Предпочтительно пероральное питание (сиппинг); при невозможности — назогастральный зонд или гастростома, затем парентеральное питание. Калорийность — 25–30 ккал/кг, белок — 1,0–1,5 г/кг в сутки.

На I этапе: протоколы ускоренного восстановления после операции, ранняя мобилизация с 1–2-х суток, обезболивание в сочетании с физиотерапией и упражнениями для мышц лица и шеи, медицинский массаж.

До и после операции показана консультация логопеда при дисфагии; активную тренировку не проводят в раннем послеоперационном периоде, при первичном заживлении и свищах.

На II этапе: упражнения против тризма, раннее лечение лимфедемы — полная противоотёчная терапия, медицинский массаж, низкочастотная магнитотерапия.

На III этапе: упражнения для мышц лица и шеи, лечебная физкультура при дисфагии, стабильная масса тела и аэробная нагрузка 150 минут в неделю.

На фоне химио- и химиолучевой терапии рекомендованы аэробные упражнения и упражнения на сопротивление в сочетании с психологической поддержкой.

Низкоинтенсивную лазеротерапию применяют при полинейропатии и мукозите полости рта на фоне ХТ, а через 3 дня от начала ЛТ — для профилактики лучевого дерматита.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Диспансерное наблюдение

Периодичность обследований

1. первые 1–2 года: **каждые 3–6 месяцев**;
2. 3–5-й год: **1 раз в 6–12 месяцев**;
3. после 5 лет: **ежегодно** или при жалобах.

Объём обследования

1. анамнез и физикальное обследование;
2. УЗИ области первичной опухоли и лимфатических узлов шеи с двух сторон;
3. КТ или МРТ головы и шеи при признаках рецидива или недоступности зоны осмотру;
4. КТ органов грудной клетки **каждые 12 месяцев**;
5. тиреотропный гормон **каждые 6–12 месяцев** после облучения шеи;
6. ПЭТ-КТ по показаниям.

При высоком риске рецидива интервалы сокращают.

Наблюдение стоматолога до, во время и после лучевой терапии

1. оценка состояния полости рта и риска кариеса;
2. удаление «проблемных» зубов **не менее чем за 2 недели** до начала лечения;
3. профилактика остеорадионекроза и устранение источников инфекции.

После ЛТ для профилактики кариеса ежедневно длительно применяют гели с фторидом олова 0,4% или фторидом натрия 1,1%.

Цель визитов — контроль заболевания и отсроченных побочных эффектов: гипотиреоза после облучения шеи, нутритивного статуса, речевой и глотательной функции. Отказ от курения и алкоголя повышает выживаемость и эффективность лечения, снижает риск рецидива и вторых опухолей.

5.2 Показания к госпитализации

Экстренная или неотложная госпитализация

1. осложнения онкологического заболевания, требующие специализированной помощи;
2. осложнения лечения: хирургического, лучевого, лекарственного.

Плановая госпитализация

1. сложные интервенционные диагностические вмешательства с наблюдением в стационаре;
2. специализированное противоопухолевое лечение, требующее наблюдения в круглосуточном или дневном стационаре.

Показания к выписке

1. завершение курса или этапа лечения при отсутствии осложнений, требующих стационарного лечения;
2. отказ пациента от лечения при отсутствии таких осложнений;
3. несоблюдение предписаний или распорядка, если это не угрожает жизни пациента и окружающих;
4. необходимость перевода в другую медицинскую организацию.

Консультация в центре амбулаторной онкологической помощи проводится **не позднее 5 рабочих дней** с даты направления; патолого-анатомическое исследование для верификации — **не более 15 рабочих дней**.

Тактику лечения определяет онкологический консилиум: онкологи и радиотерапевт, при необходимости — другие специалисты.

Факторы прогноза

1. размеры и распространённость первичной опухоли;
2. степень дифференцировки;
3. периваскулярная, перилимфатическая, периневральная инвазия;
4. статус регионарных узлов (метастазы в узлах шеи вдвое снижают выживаемость) и экстранодальное распространение;
5. индекс пролиферации Ki-67;
6. статус краёв резекции.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Злокачественные опухоли слюнных желёз»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 14.08.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2026 года
Код в рубрикаторе	116_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи; Российское общество клинической онкологии; Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи; Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Длительность терапии #дабрафенибом и #траметинибом указана одновременно как «12 мес.» и «до прогрессирования или непереносимой токсичности».
- Перечень параметров патолого-анатомического заключения различается: в разделе 2.3 — 7 параметров, в критерии качества № 5 добавлена глубина инвазии опухоли.